Sujet n°2 :

Spécialité : Anesthésie-Réanimation

Date : 18/02/2026
Auteur : Alexis PROVENCHERE (DESAR Toulouse)
Relecteur(s) : Marion BUISSET (DESAR Lyon), Lucie-Lou VIAL (DESAR Toulouse)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Urgence vitale Communication interprofessionnelle
Item(s) en lien avec la station	332 – État de choc. Principales étiologies : hypovolémique, septique, cardiogénique, anaphylactique 339 – Syndromes coronariens aigus
Situation(s) de départ en lien avec la station	43 – Découverte d'une hypotension artérielle 185 – Réalisation et interprétation d'un électrocardiogramme
Matériel nécessaire à la station	Électrocardiogramme à donner à l'étudiant dès le début de la station
Contexte de la station	Arrivée aux urgences

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne aux urgences de votre CHU.
Vous êtes appelé par l'infirmier de votre secteur pour un patient que vous n'avez pas encore examiné mais qui l'inquiète.
Il vous raconte que M. C, âgé de 47 ans, a présenté une douleur thoracique au repos il y a 35 minutes et qui n'a pas cédé depuis. Ce patient est suivi pour une coronaropathie stentée en 2023, un diabète de type 2 mal équilibré et une hypertension artérielle.

Ses constantes à l'arrivée aux urgences sont les suivantes :

- Glasgow Coma Scale à 15
- Température à 36,7°C
- Tension artérielle au bras droit à 75/59 et à 72/58 au bras gauche
- Fréquence cardiaque à 135 battements par minute
- Fréquence respiratoire à 28 cycles par minute
- Saturation en oxygène à 83% en air ambiant

Votre examen clinique rapide retrouve des marbrures au niveau des genoux, des pouls radiaux filants, un temps de recoloration cutanée à 4 secondes et des extrémités froides. Cliniquement, vous observez une polypnée superficielle et un léger tirage sus-claviculaire et intercostal. Vous notez également une turgescence jugulaire et un franc reflux hépato-jugulaire. Votre auscultation pulmonaire retrouve des crépitants diffus remontant jusqu'aux apex.

Votre infirmier a réalisé un électrocardiogramme.

Consignes :
Vous devez réaliser en 8 minutes :

- interpréter l'électrocardiogramme
- énoncer votre diagnostic
- expliquer à votre infirmier votre prise en charge initiale

Vous interagirez avec votre infirmier

Vous ne devez pas :

- compléter l'examen clinique
- interroger le patient

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Tâche 1			
1.	Identifie un sus-décalage du segment ST dans le territoire antéro-septal (valable aussi si territoire antérieur)	1 pt	☐
2.	Dit qu'il n'y a pas de trouble du rythme ET pas de trouble de la conduction	1 pt	☐
Tâche 2			
3.	Identifie un état de choc cardiogénique	1 pt	☐
4.	Explique que le choc cardiogénique est secondaire à un infarctus du myocarde *(valable aussi si précise « syndrome coronarien aigu »)*	1 pt	☐
Tâche 3			
5.	Transfère le patient en SAUV, en réanimation ou au déchocage *(valable si 1 des 3 termes est utilisé)*	1 pt	☐
6.	Demande un monitorage complet des paramètres vitaux : TA, FC, FR, SpO2, FR, T°, GCS *(point uniquement si 6/6)*	1 pt	☐
7.	Demande la pose de 2 voies veineuses périphériques de bon calibre ou évoque la pose d'une voie veineuse centrale	1 pt	☐
8.	Introduit une oxygénothérapie au masque à haute concentration à 15 L/min avec objectif de SpO2 > 94%	1 pt	☐
9.	Demande un ECG 18 dérivations, une radiographie de thorax et une gazométrie artérielle *(point si 3/3)*	1 pt	☐
10.	Demande la réalisation d'une échographie cardiaque par voie transthoracique	1 pt	☐
11.	Introduit de la dobutamine	1 pt	☐
12.	Dit clairement qu'il ne propose pas de remplissage vasculaire / ne prescrit pas de cristalloïdes	1 pt	☐
13.	Identifie la nécessité d'une coronarographie en urgence / contacte le coronarographiste de garde	1 pt	☐
14.	Prévoit une bi anti-agrégation plaquettaire et une anticoagulation en urgence	1 pt	☐
15	Demande ou prévoit une réévaluation des constantes et de la gazométrie *(point si 2/2)*	1 pt	☐

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)	
	12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL	18 points

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Les éléments les plus importants à identifier à mon sens sont de comprendre que le patient présente certes un infarctus du myocarde mais surtout une complication de son infarctus du myocarde avec ce choc cardiogénique.

Dans ce type d'ECOS de prise en charge, il faut réaliser chaque fois que c'est possible une prise en charge à la fois symptomatique (traitement du choc cardiogénique) et étiologique (traitement de l'infarctus avec la coronarographie mais ne pas oublier

le reste de la prise en charge de l'infarctus du myocarde avec la dose de charge d'aspirine, d'anti-P2Y12 et d'anticoagulant).

Dans les ECOS de réa, je vous invite à être le plus systématique possible en identifiant une par une les défaillances et en les traitant également les unes après les autres.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PARTICIPANT STANDARDISÉ SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes infirmier aux urgences et vous venez de recevoir M. C âgé de 47 ans qui vous inquiète et vous venez chercher votre interne pour qu'il réalise la prise en charge en urgence.

Plan de la station ECOS :

Professionnel de santé standardisé (infirmier) face à l'étudiant Électrocardiogramme de M. C dans la main de l'infirmier qui le tend au candidat quand il entre dans la salle

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

« Voilà l'électrocardiogramme de M. C, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses ? »

Identité du patient :

M. C Homme 47 ans 121 kg / 185cm

Mode de vie :

Chef d'entreprise, stressé, sédentaire sans activité physique
Tabagisme actif à 1 paquet par jour
Alcool occasionnel
Pas d'allergie médicamenteuse connue

Comportement global :

Vous cherchez à tirer des informations et une conduite à tenir pour améliorer la prise en charge.
Vous êtes motivé par cette prise en charge
Vous devez montrer que vous comprenez ce que le candidat vous explique et quand il vous donne des tâches à faire, vous pouvez lui répondre que vous allez vous en occuper

Antécédents personnels :

Coronaropathie stentée sur la coronaire droite en 2023
Hypertension artérielle
Diabète de type 2 mal équilibré

Antécédents familiaux :

Diabète de type 2 chez les 2 parents
Infarctus du myocarde chez le père à 53 ans
Accident vasculaire ischémique chez la mère à 60 ans

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

Aspirine 75mg 0-1-0
Atorvastatine 10mg 0-0-1
Sacubitril-Valsartan 49mg/51mg 1-0-1
Bisoprolol 5mg 1-0-0
Amlodipine 10mg 0-0-1

Metformine 1000mg 1-1-1
Empagliflozine 10mg 1-0-0

Symptômes positifs :

- Si l'étudiant demande si le patient est dyspnéique —> lui répondre que vous avez l'impression qu'il a du mal à respirer
- Si l'étudiant demande un examen complémentaire —> lui répondre qu'on va le faire
- Si l'étudiant demande le résultat d'un examen complémentaire —> lui dire que c'est en cours
- Si l'étudiant demande une réévaluation des constantes —> lui donner les constantes de la case ci-dessous en répondant seulement à ce qu'il a demandé
- Si l'étudiant demande l'auscultation cardiaque —> battements du cœur réguliers, pas de souffle
- Si l'étudiant demande comment évolue l'auscultation pulmonaire —> lui dire qu'elle est stable pour le moment
- Si l'étudiant demande comment évolue la dyspnée après les premières mesures de prise en charge —> lui répondre que le patient est moins polypnéique SI il l'a mis en position demi-assise ou SI introduction d'oxygène
- Si l'étudiant demande une réévaluation neurologique —> lui dire que le patient semble un peu plus somnolent

Constantes :

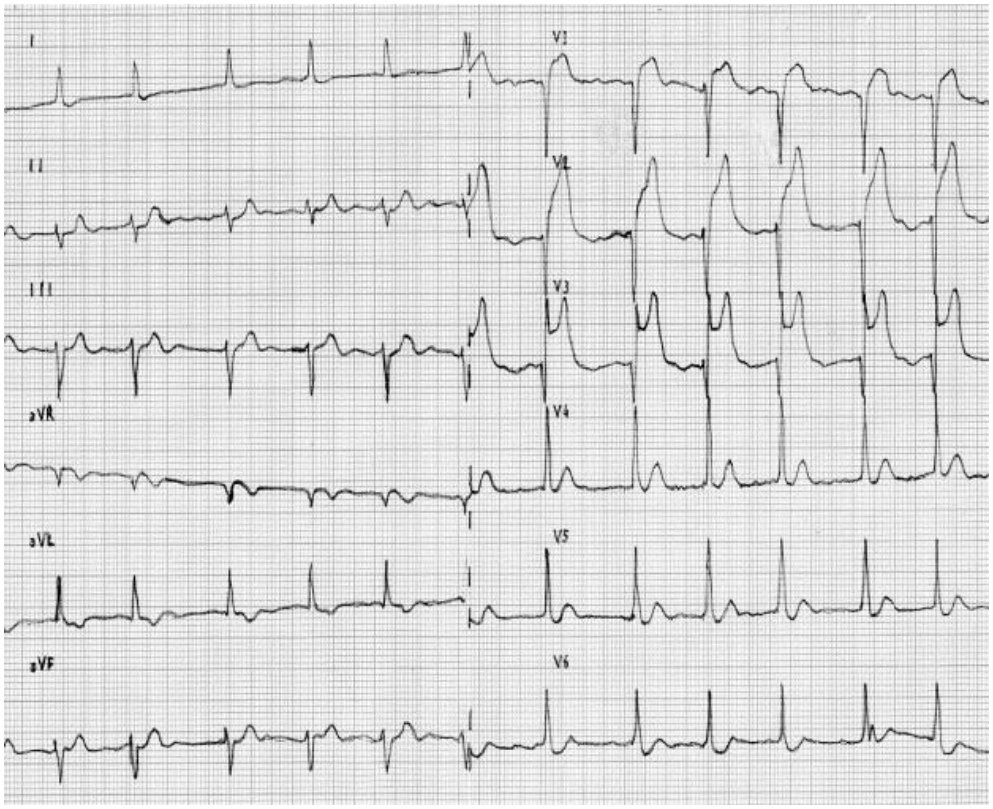
Constantes initiales :
- Glasgow Coma Scale à 15
- Température à 36,7°C
- Tension artérielle au bras droit à 75/59 et à 72/58 au bras gauche
- Fréquence cardiaque à 135 battements par minute
- Fréquence respiratoire à 28 cycles par minute
- Saturation en oxygène à 83% en air ambiant

Constantes lors de la réévaluation si l'étudiant le demande :
- Glasgow Coma Scale à 15
- Température à 36,6°C
- Tension artérielle au bras droit à 74/60 et à 71/59 au bras gauche
- Fréquence cardiaque à 138 battements par minute
- Fréquence respiratoire à 25 cycles par minute si oxygénothérapie (30 cycles par minute sinon)
- Saturation en oxygène à 95% en air ambiant si oxygénothérapie (81% sinon)

Constantes si nouvelle réévaluation en fin d'ECOS :

- Glasgow Coma Scale à 14 (Y4, M5, V5)
- Température à 36,7°C
- Tension artérielle au bras droit à 67/57 et à 65/58 au bras gauche
- Fréquence cardiaque à 142 battements par minute
- Fréquence respiratoire à 25 cycles par minute si oxygénothérapie (30 cycles par minute sinon)
- Saturation en oxygène à 96% en air ambiant si oxygénothérapie (77% sinon)

Donnée complémentaire :



A donner au candidat dès son entrée dans la salle en même temps qu'on lui donne la phrase d'accroche

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

A 6 minutes, si le candidat n'a pas introduit d'oxygène ou mis en position demi-assise : « j'ai l'impression qu'il respire vraiment mal, tu veux que je fasse quelque chose pour ça ? »

A 6 minutes, si le candidat n'a pas fait d'examen complémentaire supplémentaire : « est-ce que tu as besoin d'autres examens complémentaires ? »

A 7 minutes, si le candidat n'a pas introduit de traitement : « est-ce qu'il y a un traitement à instaurer pour ce patient ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Professionnel de santé standardisé (infirmier) face à l'étudiant Électrocardiogramme de M. C dans la main de l'infirmier qui le tend au candidat quand il entre dans la salle

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur
- Électrocardiogramme fourni

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Électrocardiogramme fourni